



Suivi des antivitamines K (AVK) : Quelles nouveautés dans la mesure du TP/INR ?

S. ZOUAGHI^{1,2}, S. BOUNAAS^{1,2}

1. Université Ferhat Abbas de Sétif. Faculté de médecine
2. Laboratoire central CHU de Sétif



INTRODUCTION / OBJECTIF

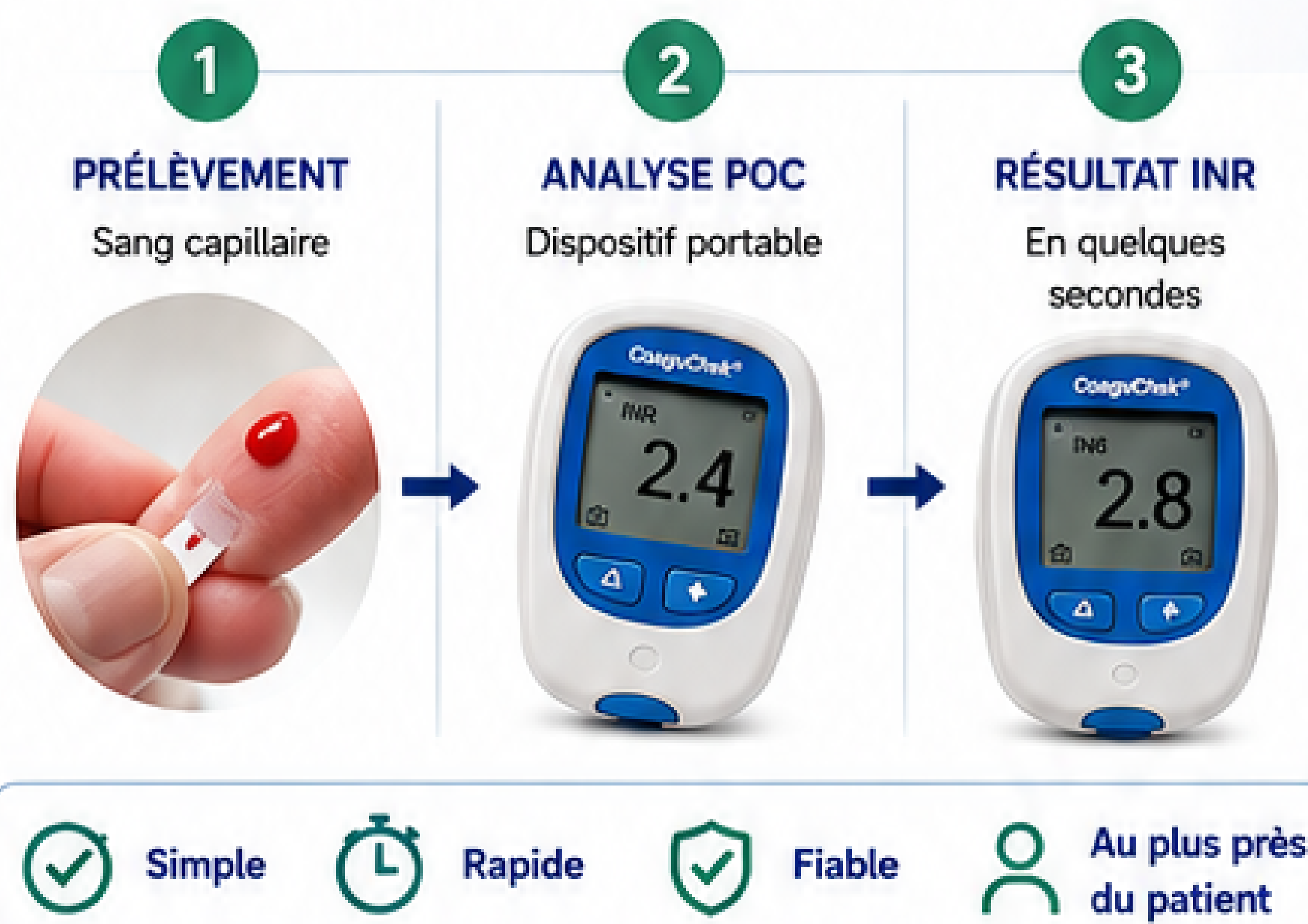
Le suivi de l'anticoagulation par antivitamines K (AVK) repose classiquement sur la mesure en laboratoire du temps de prothrombine (TP), exprimé en International Normalized Ratio (INR).

Ce suivi contraignant, réalisé par ponction veineuse répétée, a favorisé le développement de dispositifs de mesure délocalisée (point-of-care, POC) sur sang capillaire et de stratégies d'autogestion par le patient.



Cette revue vise à évaluer les innovations récentes dans la mesure du TP/INR et leur impact sur la qualité du suivi des AVK.

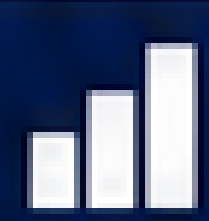
MESURE DU TP/INR AU POINT-OF-CARE (POC)



MÉTHODES

Une synthèse de la littérature (2019–2025) a été réalisée à partir des bases PubMed, Embase et Cochrane CENTRAL, portant sur :

- les dispositifs POC d'INR (CoaguChek, Coag-Sense, ProTime),
- les capteurs miniaturisés de type smartphone,
- ainsi que les essais randomisés et méta-analyses en réseau comparant autogestion (PSM), autosurveillance (PST), service spécialisé d'anticoagulation (AMS) et soins usuels.



RÉSULTATS

FIABILITÉ DES DISPOSITIFS POC

CoaguChek® XS Pro/Plus :
bonne corrélation avec l'INR plasmatique de référence.

Coag-Sense® et ProTime® :
biais significatif pouvant entraîner des erreurs de dosage dans **10 à 22 %** des cas.

RISQUE D'ERREUR DES DOSAGES

10 à 22 %

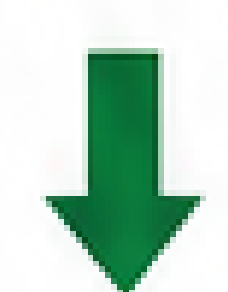


BÉNÉFICE DES STRATÉGIES D'AUTOGESTION

Méta-analyse en réseau récente (Dhippayom et al., 2024, eClinicalMedicine) chez les patients sous warfarine :



PSM
(Autogestion)

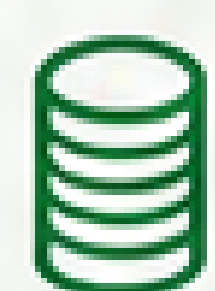


réduit significativement
les événements
thromboemboliques



+ 3,8 POINTS

d'augmentation du temps passé
en zone thérapeutique



**Bénéfice
coût-efficacité
confirmé**

DISPOSITIFS POC D'INR DISPONIBLES



CoaguChek® XS Pro / Plus

- Bonne corrélation avec l'INR plasmatique de référence



Coag-Sense®

- Biais significatif (risque d'erreur 10 à 22 %)



ProTime®

- Biais significatif (risque d'erreur 10 à 22 %)



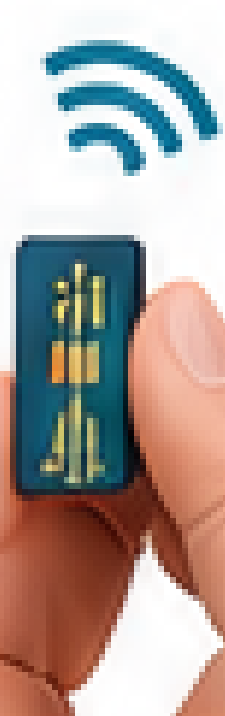
Prélèvement sur sang capillaire
(goutte de sang)

INNOVATIONS ÉMERGENTES



Capteurs miniaturisés couplés au smartphone

- Dépistage à moindre coût
- Suivi à distance
- Transmission sécurisée des données



DISCUSSION / CONCLUSION

Les nouveaux dispositifs de mesure du TP/INR et les stratégies d'autogestion améliorent l'accessibilité, la réactivité et la stabilité du suivi des AVK, avec un bénéfice clinique démontré pour l'autogestion (PSM).

Toutefois, l'hétérogénéité de fiabilité entre dispositifs POC impose une validation rigoureuse avant leur adoption clinique généralisée, en particulier hors zone thérapeutique cible.



À RETENIR



POC INR :
résultats rapides
au plus près du patient



Autogestion (PSM) :
meilleure efficacité
clinique et économique



Qualité variable
entre dispositifs :
valider avant d'adopter



**Vers un suivi
personnalisé, connecté
et patient-centré**



RÉFÉRENCES

Dhippayom T. et al. Network meta-analysis of patient self-management, patient self-testing, anticoagulation management services and usual care for warfarin treatment. eClinicalMedicine. 2024.

MOTS CLÉS



AVK ; INR ; Point-of-care testing ;
Autosurveillance ; Autogestion de
l'anticoagulation.